

БЕЛИНФОНД · 2026 · ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

БИЗНЕС-ПЛАН

инновационного проекта

**Protocol - предимпортная экспертиза консультативных
заключений и сервис проверки КЗ для пациентов**

Участник: Общество с дополнительной ответственностью «Медицинский
центр «Кравира»» (МЦ «Кравира»)

г. Минск, проспект Победителей, 45, пом. 25 · УНП 101477932

Руководитель: Касацкая Мария Геннадьевна, директор

Контакт: Кузавка Павел Леонидович, заместитель директора по цифровой
трансформации бизнеса и информационным технологиям

+375 29 608-75-95 · akuazuk@gmail.com · <https://kravira.by>

Минск · 2026

Миссия Protocol

Сделать качество амбулаторной помощи в Беларуси **измеримым и прозрачным** – для каждого консультативного заключения, до подписи врачом и до попадания данных в ЦИСЗ. Не заменяя врача и МЭЭ, мы даём инструмент соответствия **478 клиническим протоколам Минздрава** на потоке **100% КЗ**, а пациенту – право проверить своё заключение по тем же стандартам.

Рынок платных медуслуг РБ в 2025 г. – около 2,7 млрд BYN (+24% г/г, оценка Юнитер). Частный сектор – 70-81% платного сегмента (КОЛЛИЕРЗ / SmartPress); в Минске концентрируется ~56% объёма. Рост частных центров ~20%/год. Очереди и дефицит методистов в госсекторе перекадывают спрос на платную амбулаторию. При 25 000 КЗ/мес в МЦ «Кравира» как 1% рынка адресуемый поток частных ОЗ – ~2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год). Protocol монетизирует контроль качества на этом потоке, не конкурируя с лечением, а повышая его соответствие стандартам.

Централизованная информационная система здравоохранения (ЦИСЗ) создаёт единое информационное пространство системы здравоохранения РБ (распоряжение Президента №6рп от 08.01.2024). Цели: улучшение качества медуслуг и управляемость отрасли. Частные организации здравоохранения подключаются к протоколам взаимодействия МИС с ЦИСЗ (v.1.2-1.3, FHIR BY). Protocol закрывает разрыв между «врач написал текст» и «пакет принят государством»: проверка до подписи ЭЦП снижает доработки и повышает достоверность регистров для аналитики Минздрава.

Содержание

1. Титульный лист	1
2. Содержание	2
3. Резюме	3
4. Описание проекта	5
5. Описание продукции	9
6. Анализ рынка и маркетинг	13
7. Интеллектуальная собственность	18
8. Потребители и сбыт	19
9. Ценообразование	21
10. Конкуренты	24
11. Поставщики	26
12. Производственный план	27
13. Организационный план	29
14. Риски	31
15. Финансовый план	32
16. Иные сведения	36

Приложения А-Ж: прайс, дорожная карта, KPI, графики, ROI, рынок РБ

Электронные приложения: 05_Biznes_plan_Prilozheniya.html, 06_ROI_Kravira.html

Рекомендуемый объем: 10-40 страниц основного текста; детальные расчёты - в приложениях.

3. Резюме

Идея проекта. Автоматизировать предимпортную экспертизу консультативных заключений (КЗ) до подписи ЭЦП в частных медицинских организациях Республики Беларусь и предоставить физическим лицам сервис самопроверки качества оказанной помощи по официальным клиническим протоколам Минздрава.

Проблема и возможность. В РБ действует порядка 478 клинических протоколов; рынок платных медуслуг оценивается в ~2,7 млрд BYN в 2025 г. (+24% г/г). Доля частного сектора в платном сегменте - 70-81%. МЦ «Кравира» формирует 25 000 КЗ/мес - по оценке участника это ~1% платных консультаций частного сектора, откуда адресуемый рынок ~2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год). Методслужба не успевает проверять каждое заключение; отклонения пакетов в ЦИСЗ создают репутационные и финансовые риски.

Решение. Программный комплекс Protocol: детерминированный scoring (482+ правил, 8 блоков), чек-лист готовности к ЦИСЗ (FHIR BY), единое решение send_gate для МИС. LLM - только пояснения; блокировка подписи - по правилам.

Монетизация (три канала). B2B: 0,99 / 0,79 / 0,69 BYN за проверку L0 (якорь Кравира - 207 тыс. BYN/год). B2B API: лицензия МИС «Айболит». B2C: 4,99 / 9,99 BYN для физлиц.

Финансовый вывод. Год 3: выручка ~2,33 млн BYN, EBITDA +1,68 млн при 8% рынка (200 000 КЗ/мес). Точка безубыточности направления - 2-3 клиники уровня «Клиника» или OEM API.

Запрос. Сертификат ГКНТ (571 б.в., ~24 тыс. BYN) на интеграцию МИС, on-prem L0, масштабирование на 5-10 частных ОЗ к 2028 г.

Социальная значимость: кому и как помогает Protocol



Пациенты и семьи

Прозрачность качества помощи без ожидания МЭЭ

- В2С-сервис: загрузить своё консультативное заключение и получить понятный отчёт – соответствует ли оказанная помощь официальным клиническим протоколам Минздрава РБ (478 документов).
- Пациент видит не «оценку врача», а сопоставление с государственным стандартом – с цитатами из протокола, что именно должно было быть в КЗ.
- Снижение тревожности: «мне назначили то, что положено по стандарту» или «есть повод задать врачу уточняющие вопросы» – до обращения в МЭЭ или смены клиники.
- QR на чеке/КЗ в партнёрской клинике – проверка за 4,99 BYN без очереди к методисту.
- Особенно ценно при хронических заболеваниях, онкологии, беременности – где протоколы детализированы и ошибка в назначениях критична.
- Дисклеймер: не замена врача и не юридическое заключение; инструмент информированного участия пациента в своём лечении.



Врачи и средний медперсонал

Подсказка в потоке, а не контроль «сверху»

- L0 <2 с при сохранении КЗ в МИС: врач видит send_gate (можно подписать / предупреждение / блок) до ЭЦП – исправляет КЗ пока контекст свежий.
- 482+ детерминированных правил с цитатами из PDF Минздрава – не нужно держать в голове сотни протоколов; система подсказывает пробел в обследованиях, лечении, оформлении.
- LLM только для пояснений (L2); решение о блокировке – по правилам. Врач не зависит от «чёрного ящика» нейросети.
- Снижение стресса от отклонения пакета в ЦИСЗ после подписи: cisz_readiness проверяет Bundle/Composition до отправки.
- Меньше возвратов от методслужбы и администраторов – время на пациента, а не на переписку по формальным замечаниям.
- Обучающий эффект: повторяющиеся gate_score <70 показывают зоны для повышения квалификации без публичного наказания.



Медицинские центры и методслужбы

100% потока вместо выборочного аудита
2-5%

- Масштаб: ручной аудит методистом охватывает 2-5% КЗ при стоимости ~34 BYN/проверенное заключение; Protocol L0 - 0,69 BYN при 100% потока (25 000+ КЗ/мес в Кравире).
- Единый send_gate: клинические протоколы + ЦИСЗ FHIR BY в одном решении для МИС - не два разрозненных контроля.
- Репутация и NPS: меньше отклонённых пакетов в государственный контур, меньше доработок «после факта».
- B2C white-label: клиника предлагает пациенту «Проверить заключение» - дифференциатор сервиса и дополнительный канал доверия.
- KPI для руководства: gate_score, cisz_score, динамика по блокам (диагноз, лечение, безопасность) - управленческая аналитика качества.
- On-prem в РБ: персональные данные не покидают контур клиники на уровне L0.



Государство и система здравоохранения

Качество данных в ЦИСЗ и исполнение КП
Минздрава

- ЦИСЗ (распоряжение Президента РБ №6рп от 08.01.2024): частные ОЗ подключаются к единому информационному пространству; Protocol снижает долю некачественных структурированных пакетов до попадания в национальный контур.
- 478 клинических протоколов Минздрава - нормативная база качества; автоматизированный контроль исполнения на амбулаторном уровне дополняет выборочную МЭЭ.
- Прозрачность для регулятора: детерминированный scoring с evidence_map - воспроизводимый аудит, не субъективная оценка LLM.
- Снижение нагрузки на методслужбы Минздрава и учреждений: первичный фильтр качества КЗ - на стороне ОЗ до передачи в ЦИСЗ.
- Импортозамещение: отечественный продукт с корпусом КП РБ; зарубежные CDSS (UpToDate, Isabel) не содержат белорусских протоколов и FHIR BY.
- Перспектива масштабирования на госсектор после пилота в частных ОЗ - единая методология качества КЗ по стране.

Мировые аналоги и отличие Protocol

CDSS (Clinical Decision Support) существуют более 40 лет (AHRQ/ONC); >90% больниц США используют EHR с CDS. Зарубежные решения не закрывают связку «КП конкретной страны + предподпись ЭЦП + FHIR + B2C для пациента» для Беларуси.

Таблица. Сравнение с мировыми CDSS

Решение	Регион	Тип	Почему не заменяет Protocol
UpToDate / DynaMed	США, глобально	CDSS, справочник + рекомендации	Справочник для врача, не проверка каждого КЗ
Isabel / DXplain	Великобритания	Дифференциальная диагностика	Диагностика, не compliance КЗ
Epic / Cerner CDS hooks	США	Встроенные правила в EHR	Инфраструктура EHR, не КП государства
Infera / Zebra Medical	Израиль / глобально	AI-CDSS по guidelines	AI без evidence_map по КП РБ
MedAware / BD Medication	Израиль / США	Безопасность назначений	Pharmacovigilance, не полный КЗ
OpenAI / ChatGPT (ad hoc)	Глобально	Свободный LLM-чат	Не медицинский продукт
Protocol (МЦ «Кравира»)	Беларусь	Предпроверка КЗ + ЦИСЗ + B2C	Едиственный контур «КП РБ + ЭЦП + FHIR BY + пациент»

4. Описание проекта

Ситуация в отрасли. Цифровизация здравоохранения Республики Беларусь ускорилась с внедрением Централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ) и профиля FHIR BY 5.0. Частные амбулаторно-поликлинические организации обязаны формировать консультативные заключения (КЗ) по стандартам и передавать структурированные данные в государственный контур. В системе здравоохранения РБ действуют 1 394 амбулаторно-поликлинические организации; платный сегмент концентрируется в частных центрах, преимущественно в Минске (~56% объема).

Макроэкономика платной медицины. По отраслевым оценкам, рынок платных медуслуг РБ в 2025 г. составил ~2,7 млрд BYN при росте ~24% к предыдущему году. Доля частного сектора в платных услугах - 70-81% (данные КОЛЛЕПЗ / SmartPress). Рост выручки частных центров в Минске - около 20% в год (2018-2023). Это создаёт устойчивый поток КЗ, который невозможно контролировать вручную на каждом этапе.

Существующая проблема: (1) методслужба не масштабируется на поток 25 000+ КЗ/мес в крупной клинике; (2) отклонения пакетов в ЦИСЗ влекут доработки и репутационные риски; (3) пациенты не имеют инструмента проверки соответствия оказанной помощи протоколам; (4) врач не может оперативно сверять каждое заключение с полным корпусом из ~478 клинических протоколов Минздрава.

Цель проекта: коммерциализация Protocol как B2B-сервиса для клиник и B2C-сервиса для физических лиц на национальном рынке РБ.

Задачи на 2026-2028: пилот и production L0 в МЦ «Кравира»; интеграция API в МИС «Айболит»; запуск B2C-витрины с оплатой; подключение 3-10 B2B-клиентов; регистрация программы для ЭВМ в НЦИС; достижение 3% рынка к 2028 г. и 8% к 2029 г.

Ожидаемый эффект для отрасли: снижение доли отклонённых пакетов ЦИСЗ, повышение прозрачности качества помощи для пациентов, высвобождение 0,3-0,5 FTE методиста на крупную клинику.

Социальная значимость (подробно - раздел «Социальная значимость» в PDF-версии бизнес-плана): - Пациенты получают B2C-инструмент проверки КЗ по 478 протоколам Минздрава с цитатами из стандарта. - Врачи - подсказку L0 <2 с до ЭЦП, без «чёрного ящика» LLM в решении send_gate. - Медцентры - 100% охват потока вместо 2-5% выборочного аудита; единый контур клиника + ЦИСЗ. - Государство - более качественные данные в ЦИСЗ и исполнение клинических протоколов на амбулаторном уровне.

5. Описание продукции (услуг)

Наименование продукции: программный комплекс Protocol (SaaS / on-prem) - информационная система поддержки контроля качества медицинской документации. Позиционирование: не медиздание, не замена врача и МЭЭ, не юридическое заключение для B2C.

Отличия от аналогов на рынке: - корпус ~478 PDF клинических протоколов Минздрава РБ с цитатами в отчёте (evidence_map); - детерминированный scoring (8 блоков, 482+ правил, gate_score, soft_gate); - два контура в одном send_gate: клинические протоколы + готовность ЦИСЗ (FHIR BY 3.2.1); - tiering L0/L1/L2: массовая проверка <2 с без LLM (L0) для каждого КЗ в МИС; - единый REST API для интеграции с МИС «Айболит» и другими вендорами.

Функции B2B: поиск КП по МКБ-10, cisz_readiness, send_gate (allow / warn / block), REST API L0-L2, отчёт для методслужбы с цитатами из протоколов.

Функции B2C: загрузка PDF своего КЗ физлицом; отчёт на русском языке о соответствии помощи протоколам; дисклеймер (не диагноз, не юридическое заключение); удаление файла после сессии.

Технология: Python/FastAPI, гибридный RAG, детерминированные правила; опционально LLM для L2. Развёртывание в защищённом контуре РБ (см. [architecture-kravira-fhir-mis.pdf](#)).
Серверные требования: 2-4 GB RAM на площадку, Docker.

Жизненный цикл продукта: еженедельная синхронизация корпуса КП Минздрава; еженедельные релизы правил; квартальный аудит методистом.

6. Анализ рынка и маркетинг

Продукты и услуги отрасли: амбулаторная помощь, ведение ЭМК, МИС, передача данных в ЦИСЗ, методический контроль КЗ, медицинский туризм (>160 тыс. иностранных пациентов в 2024 г.).

География: национальный рынок (РБ); приоритет - Минск и крупные частные сети; экспорт в русскоязычные юрисдикции с похожей нормативкой - перспектива 2029+.

B2B-сегмент: частные ОЗ. МЦ «Кравира» - 25 000 КЗ/мес, ~1% рынка частных ОЗ, отсюда оценка сегмента ~2,5 млн КЗ/мес (~30 млн/год). SAM (5% TAM, клиники с потоком >5 000 КЗ/мес и готовностью к ЦИСЗ) - 1,5 млн КЗ/год. SOM год 3 - 2,4 млн КЗ/год (8% TAM).

B2C-сегмент: получатели КЗ в частных ОЗ (~30 млн касаний/год). При конверсии 0,1% - 30 000 платных проверок × 4,99 BYN ≈ 150 тыс. BYN/год; при 0,5% - 750 тыс. BYN/год дополнительно к B2B. Воронка: QR на чеке → landing → оплата ERIP.

Маркетинг B2B: кейс Кравиры с ROI (экономия методиста + снижение доработок ЦИСЗ); конференции ЦИСЗ/Минздрава; прямые продажи; партнёрство с EPAM/Айболит (OEM API); пилот 1-3 месяца с KPI.

Маркетинг B2C: QR «Проверить заключение»; SEO «как читать КЗ»; соцсети; white-label от клиник-партнёров (промо 2,99 BYN).

Тренды: ужесточение требований ЦИСЗ; дефицит методистов; принятие ИИ при прозрачном детерминированном scoring; рост частных центров ~20%/год в Минске.

Детальная таблица рынка TAM/SAM/SOM, контекст РБ и графики - таблицы 1-1a, 9 и приложения.

7. Интеллектуальная собственность

Используются объекты ИС участника. Исходный код и база правил - исключительные права МЦ «Кравира» (договоры с разработчиками). Регистрация программы для ЭВМ в НЦИС (БелГИСС). Режим коммерческой тайны для каталога правил и конфигураций gate. Патентная чистота: открытые PDF Минздрава, FHIR BY, собственная реализация scoring и send_gate. Лицензирование B2B - договор оказания услуг / лицензионный договор на API.

8. Потребители и сбыт

Основные потребители B2B: частные медицинские центры и сети ОЗ; методслужбы; вендоры МИС (Айболит/ЕРАМ). Якорный потребитель - МЦ «Кравира» (~25 000 КЗ/мес, 207 тыс. BYN/год B2B).

Сегментация B2B: (1) крупные сети 25k+ КЗ/мес - тариф «Сеть» 0,69 BYN; (2) клиники 5-10k - «Клиника» 0,79 BYN; (3) малые ОЗ до 1k - «Старт» 0,99 BYN; (4) OEM через МИС - лицензия + внедрение.

Потребители B2C: физические лица - пациенты частных клиник, желающие проверить своё консультативное заключение на соответствие клиническим протоколам Минздрава; вторичный сегмент - родственники пациентов и медтуристы.

Сбытовая политика B2B: прямые договоры; пакетные тарифы; OEM/API для МИС; пилот 1-3 месяца с метриками отказов ЦИСЗ; минимальные обязательства по объёму для скидки.

Сбытовая политика B2C: публичная веб-витрина; ERIP и банковские карты; промо через клиники-партнёры (white-label, скидка 2,99 BYN); QR-код на выдаваемом пациенту КЗ.

Каналы продвижения: личные продажи (B2B), партнёрская программа с клиниками (rev-share на B2C), контент-маркетинг, участие в конкурсе Белинфонд для PR.

9. Ценообразование

Ценовая политика основана на микроплатеже за одну проверку КЗ (модель pay-per-use), что снижает барьер входа для клиник по сравнению с крупными лицензиями МИС.

B2B (за 1 проверку КЗ, уровень L0): - Розница: 0,99 BYN - Пакет 10 000/мес: 0,79 BYN (мин. 5 000 BYN/мес) - Пакет 25 000+/мес: 0,69 BYN (мин. 12 000 BYN/мес, тариф МЦ «Кравира») - L2 для методиста: +0,50 BYN - Внедрение API в МИС: 15-40 тыс. BYN разово + поддержка 3-5 тыс. BYN/год

B2C (физические лица): - Базовая проверка L1: 4,99 BYN - Подробный отчёт L2: 9,99 BYN - Абонемент 3 проверки/мес: 12,99 BYN - Промо от клиники-партнёра: 2,99 BYN

Себестоимость L0 B2B: ~0,06-0,12 BYN/КЗ (маржа 85-94% при 0,99 BYN; 83-91% при 0,69 BYN). Себестоимость B2C L1: ~0,15-0,25 BYN (обработка PDF, без долгого хранения ПДн).

Обоснование цены: ручной аудит методистом - эквивалент ~34 BYN/проверенное КЗ при охвате 2-5% потока; Protocol L0 - 0,69 BYN при 100% охвате.

Прайс-листы, таблица себестоимости, маржа по тарифам и график тарифной лестницы - таблицы 2-4, 9 и приложение А.

10. Конкурененты

Конкурентный анализ показывает отсутствие в Республике Беларусь готового продукта «корпус КП Минздрава + предпроверка Bundle до ЭЦП + B2C для пациентов».

Основные альтернативы: ручной аудит методслужбы (2-5% потока, ~34 BYN/КЗ); зарубежные CDSS без КП РБ; свободные LLM-чаты (риск ПДн, нет send_gate); встроенные шаблоны МИС без evidence_map.

Конкурентные преимущества Protocol: 100% охват потока L0; локальный корпус КП; интеграция ЦИС3; прозрачный детерминированный scoring; три канала монетизации.

Подробная сравнительная таблица с оценкой по 5 критериям - таблица 5.

11. Поставщики

Поставщики и контрагенты: - хостинг / виртуальные машины в дата-центре РБ (on-prem площадка клиники или облако РБ); - платёжные агрегаторы для B2C (ERIP, эквайринг банков РБ); - опционально API языковой модели (Gemini) или on-prem LLM для уровня L2; - НЦИС (БелГИСС) - регистрация программы для ЭВМ; - ЕРАМ / вендор МИС «Айболит» - интеграционные работы; - юридическое сопровождение договоров B2B/B2C и политики ПДн.

Материалы: не требуются (программный продукт). Сервер 2-4 GB RAM на площадку. Лицензии ПО - open source (Python, FastAPI) + собственная разработка.

План закупок на 2026-2027: серверное оборудование ~10 тыс. BYN; интеграция МИС ~40 тыс. BYN; маркетинг пилота ~20 тыс. BYN (см. таблицу инвестиций).

12. Производственный план

Производственный процесс - тиражирование экземпляров ПО и сопровождение: 1. Развёртывание Docker/on-prem на площадке заказчика (1-2 недели). 2. Еженедельная синхронизация корпуса PDF Минздрава. 3. Обновление каталога правил и конфигураций gate (релизы). 4. Для B2C - изолированный публичный контур с удалением загруженных файлов после сессии. 5. Мониторинг SLA L0 <2 с, uptime 99,5%.

Материально-техническая база: серверная инфраструктура МЦ «Кравира»; рабочий прототип развёрнут. Потребность в новом оборудовании - умеренная (1 сервер на площадку, ~3-5 тыс. BYN).

Производственная мощность: один сервер L0 обрабатывает до 500 000 КЗ/мес; масштабирование горизонтальное.

13. Организационный план

Организация-исполнитель: ОДО «Медицинский центр «Кравира»». Кадровая структура проекта - таблица 6.

График работ (ключевые вехи): - Q3-Q4 2026: production L0 on-prem, подготовка B2C beta, регистрация ПО; - Q1-Q2 2027: API в МИС «Айболит», метрики пилота, ROI-отчёт; - Q3-Q4 2027: коммерческие договоры с 2-3 внешними ОЗ, B2C ERIP; - 2028: масштабирование на 5-10 клиник, 3% рынка; - 2029: 8% рынка, white-label МИС.

Ответственный по проекту: Кузавка П.Л. (цифровая трансформация и ИТ). Методологическое руководство: главврач / методслужба Кравиры.

ФОТ проекта (оценка): ~180 тыс. BYN в год 1, рост до 420 тыс. BYN в год 3 (см. таблицу ОРЕХ).

14. Риски

Финансовые и иные риски проекта систематизированы в таблице 7.

Ключевые риски: обработка ПДн в B2C; изменение клинических протоколов Минздрава; низкая готовность платить малыми клиниками; регуляторная квалификация продукта; поддержка интеграции МИС; конкуренция со стороны вендоров МИС.

Митигация: on-prem L0 без выноса ПДн; автосинхронизация корпуса КП; ROI через снижение отказов ЦИС3 (см. 06_ROI_Kravira.html); позиционирование как СПО/ИС; пилот с EPAM; QR-кампании для B2C через партнёрские клиники; резерв на юридическое сопровождение 30 тыс. BYN.

Страховые меры: договоры SLA с клиентами B2B; политика обработки ПДн; регистрация ПО в НЦИС.

15. Финансовый план

Финансовый план на 3 года (осторожный сценарий) представлен в таблицах 8, 10-12 и на графиках в приложениях Г, З, И.

Исходное допущение рынка: 25 000 КЗ/мес в Кравире = 1% платных КЗ частного сектора РБ, адресуемый рынок 2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год).

Доходы год 1 (2027): B2B Кравира 207 тыс. + B2C beta 50 тыс. = 257 тыс. BYN; OPEX 280 тыс.; EBITDA -23 тыс. (инвестиционная фаза).

Доходы год 2 (2028): B2B 675 + B2C 180 + API 25 = 880 тыс. BYN; OPEX 420 тыс.; EBITDA +460 тыс. (3% рынка, 75 000 КЗ/мес).

Доходы год 3 (2029): B2B 1 800 + B2C 450 + API 75 = 2 325 тыс. BYN; OPEX 650 тыс.; EBITDA +1 675 тыс. (8% рынка, 200 000 КЗ/мес).

Структура OPEX: ФОТ 64%, инфраструктура 13%, маркетинг 13%, прочее 10% (см. таблицу 11 и график OPEX).

Инвестиции 2026-2027: интеграция МИС 40 тыс.; B2C-витрина 25 тыс.; регистрация ПО 15 тыс.; сервер 10 тыс.; маркетинг 20 тыс. Итого ~110 тыс. BYN. Источники: сертификат ГКНТ (571 б.в. × 42 BYN ≈ 24 тыс. BYN), собственные средства Кравиры, reinvest EBITDA с 2028 г.

ROI якорного клиента - приложение Ж (06_ROI_Kravira.html): экономия ~3,5 тыс. BYN/мес vs затраты 17,25 тыс. BYN/мес на Protocol при полном охвате - окупаемость через снижение доработок ЦИС3 и высвобождение методиста.

Cash flow: отрицательный в 2027 (-23 тыс. EBITDA), положительный с 2028 (+460 тыс., +1 675 тыс.).

16. Иные сведения

Иные сведения: бизнес-план дополнен приложениями А-Ж в соответствии с рекомендациями Белинфонда (объём 10-40 страниц, расчёты в приложениях).

Электронная версия приложений: 05_Biznes_plan_Prilozeniya.html (графики Chart.js, таблицы рынка РБ, P&L, cash flow), ROI: 06_ROI_Kravira.html, чек-лист: docx-preprint-checklist.md.

Архитектура: architecture-kravira-fhir-mis.pdf. Презентация MVP: mvp-presentation.html.

Источники рыночных данных: отраслевые обзоры платной медицины РБ (Uniter, Smart-Press, КОЛЛИЕРЗ); данные Минздрава РБ; внутренние метрики МЦ «Кравира» (25 000 КЗ/мес).

Контакт для уточнений: Кузавка П.Л., akuazuk@gmail.com, +375 29 608-75-95.

Финансовые приложения и графики

2 7 млрд

BYN рынок платных услуг

2 500 000

КЗ/мес ТАМ

207 000

BYN/год якорь

+1675

тыс. BYN EBITDA 2029

Контекст рынка платных медуслуг РБ

Показатель рынка РБ	Значение	Источник
Рынок платных медуслуг РБ, 2025 (оценка)	~2,7 млрд BYN	отраслевые обзоры
Доля частных центров в платном сегменте	~70-81%	КОЛЛИЕР3 / SmartPress
Доля Минска в платных услугах	~56%	концентрация спроса
Амбулаторно-поликлинические ОЗ в РБ	1 394	Минздрав РБ
Рост выручки частных центров (Минск)	~20% / год	SmartPress, 2018-2023
Иностранные пациенты, 2024	>160 тыс.	НАТУР / медтуризм

TAM / SAM / SOM

Показатель	Значение	Комментарий
КЗ/мес, Кравира	25 000	1% рынка
КЗ/мес, частные ОЗ РБ	2 500 000	экстраполяция
TAM @ 0,99 BYN/год	~29 700 000 BYN	30 млн × 0,99
SAM 5%	1 500 000 КЗ/год	крупные ОЗ
SOM год 3	2 400 000 КЗ/год	8% TAM

Финансовый план (тыс. BYN)

Показатель	2027	2028	2029
Клиенты (ОЗ)	1	3	8
КЗ/мес	25 000	75 000	200 000
Выручка B2B, тыс.	207	675	1800
Выручка B2C, тыс.	50	180	450
Выручка API, тыс.	0	25	75
ОРЕХ, тыс.	280	420	650
EBITDA, тыс.	-23	+460	+1675

Инвестиции 2026-2027

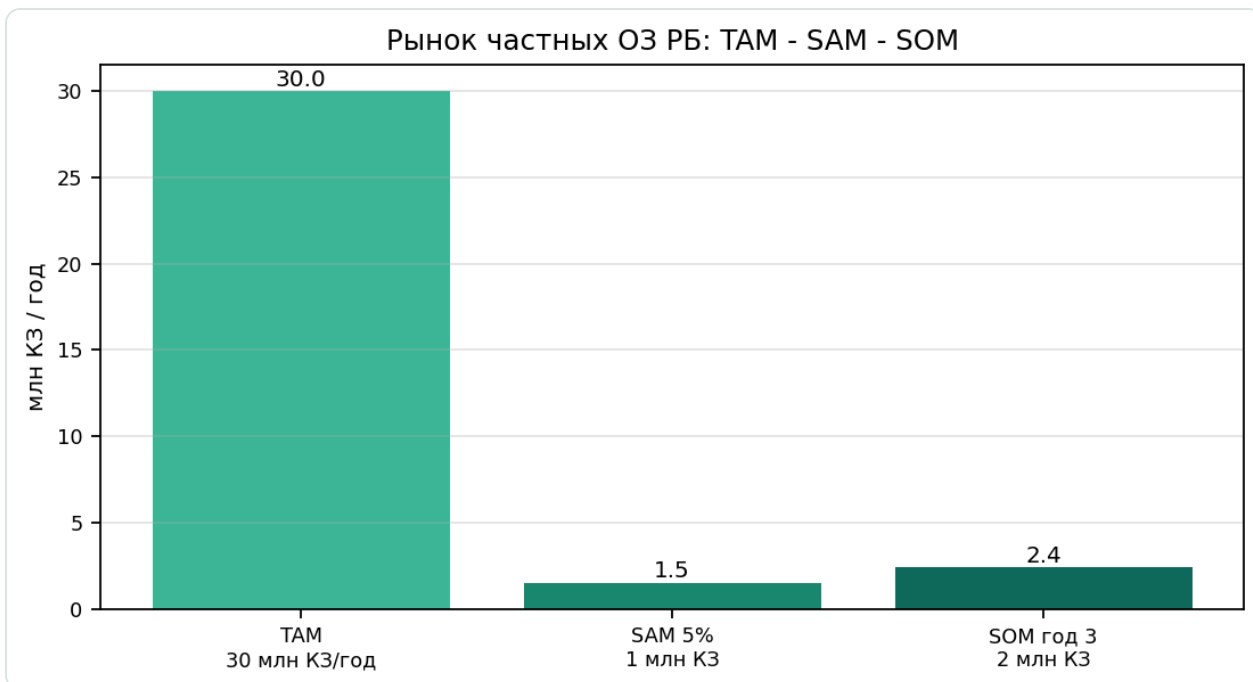
Статья инвестиций	BYN	Срок
Интеграция API в МИС «Айболит»	40 000	Q3 2026 - Q1 2027
B2C-витрина, ERIP, политика ПДн	25 000	Q4 2026
Регистрация программы для ЭВМ (НЦИС)	15 000	Q3 2026
Серверная инфраструктура якоря	10 000	Q4 2026
Маркетинг пилота (кейс Кравира)	20 000	2027

Драйвер	Пояснение
Обязательная передача амбулаторных данных в ЦИСЗ (FHIR BY)	Рост штрафных и репутационных рисков
Отклонение пакетов при ошибках Bundle/Composition/НСИ	Доработки после подписи ЭЦП
Дефицит методистов при росте потока КЗ	Ручной аудит 2-5% потока
478 клинических протоколов Минздрава	Невозможность ручного контроля каждого КЗ

Конкуренты

Альтернатива	Охват	Слабость	Стоимость
Ручной аудит методслужбы	2-5% потока	Не масштабируется	34 BYN/проверенное КЗ
Зарубежные CDSS (UpToDate и др.)	N/A	Нет КП Минздрава РБ	Подписка USD
ChatGPT / общие LLM	Ad hoc	Нет send_gate, ПДн	Непредсказуемо
Шаблоны МИС	100% форма	Нет evidence_map	В лицензии МИС
Protocol L0	100% потока	КП РБ + ЦИСЗ + правила	0,69 BYN/КЗ

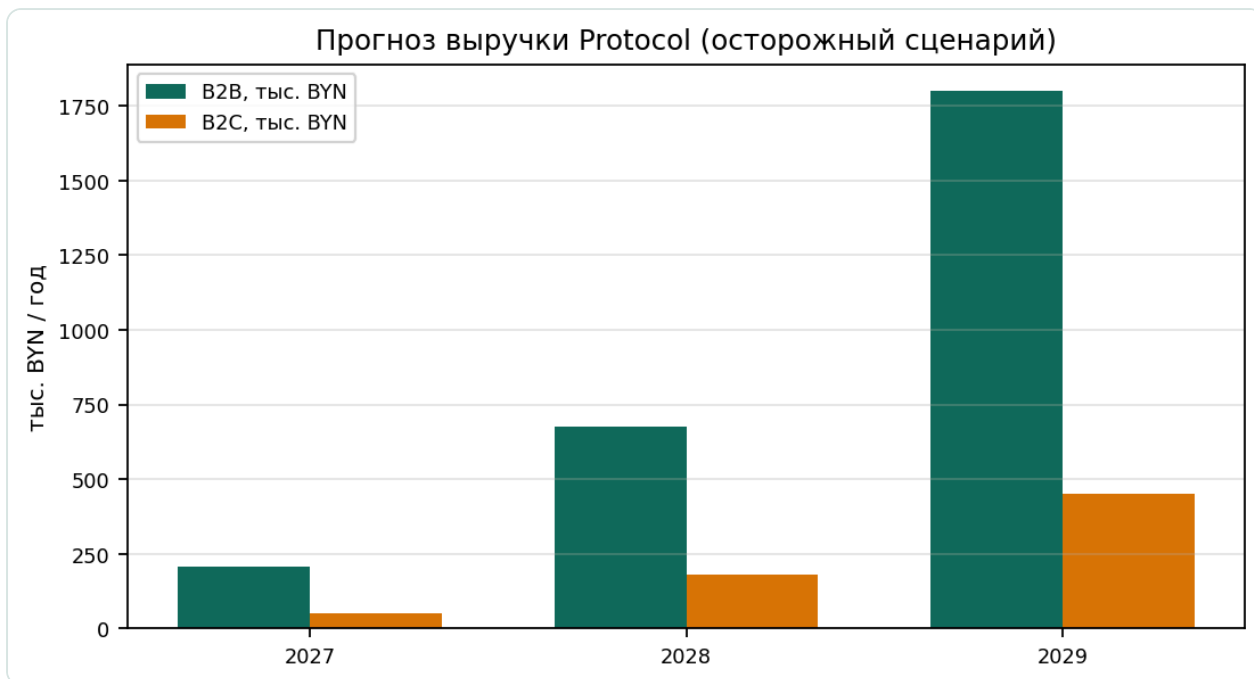
Рынок TAM / SAM / SOM



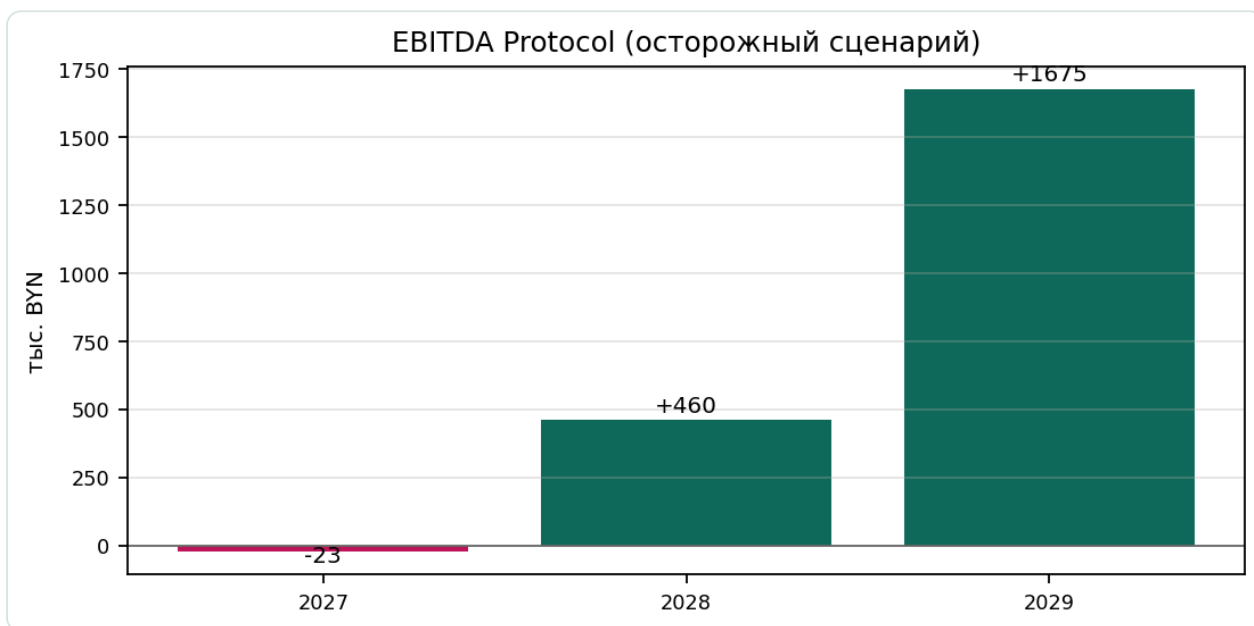
Рост доли рынка и объёма КЗ



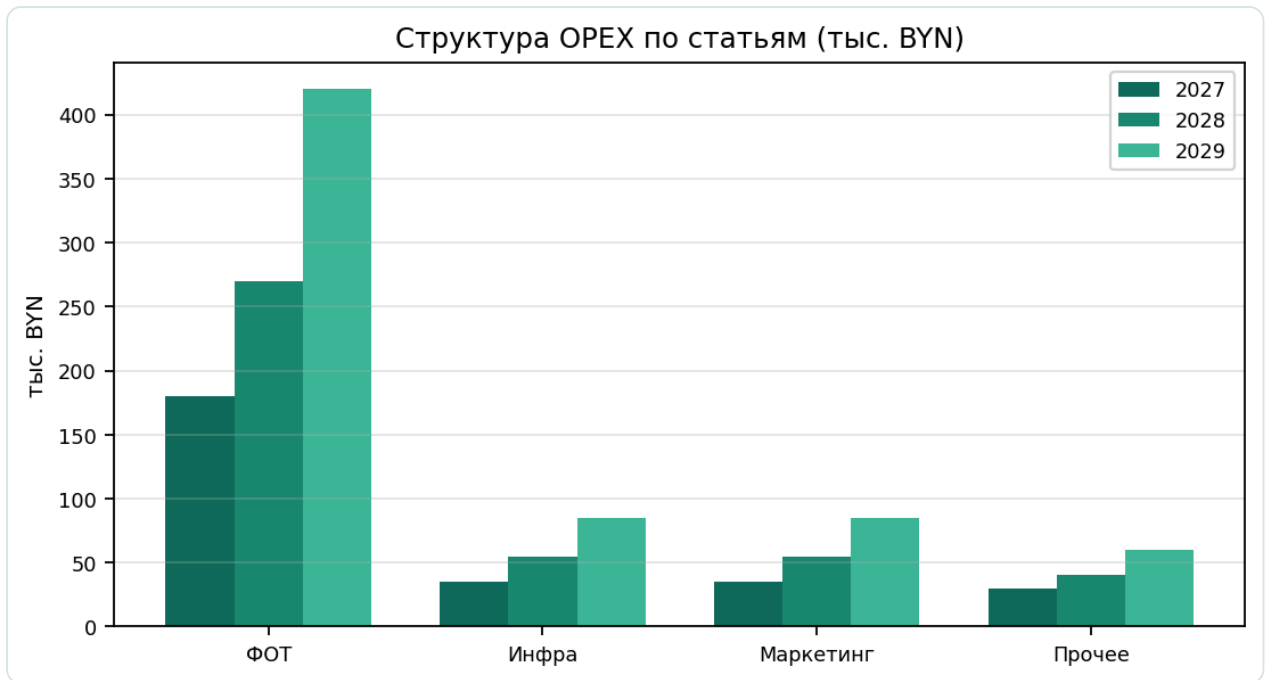
Выручка B2B / B2C по годам



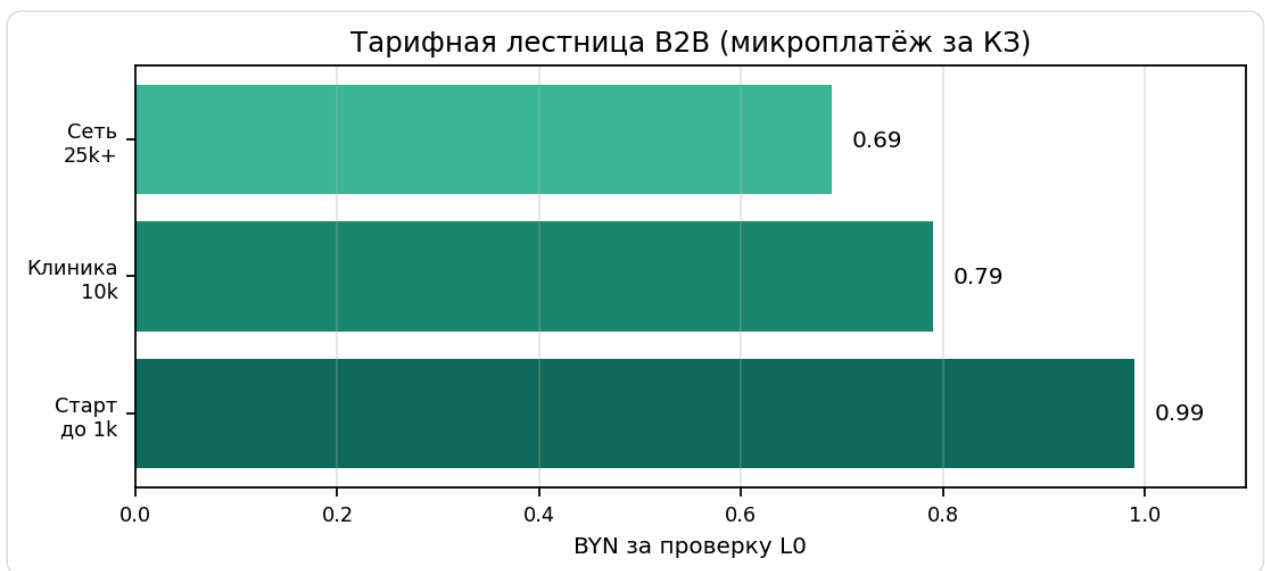
EBITDA по годам



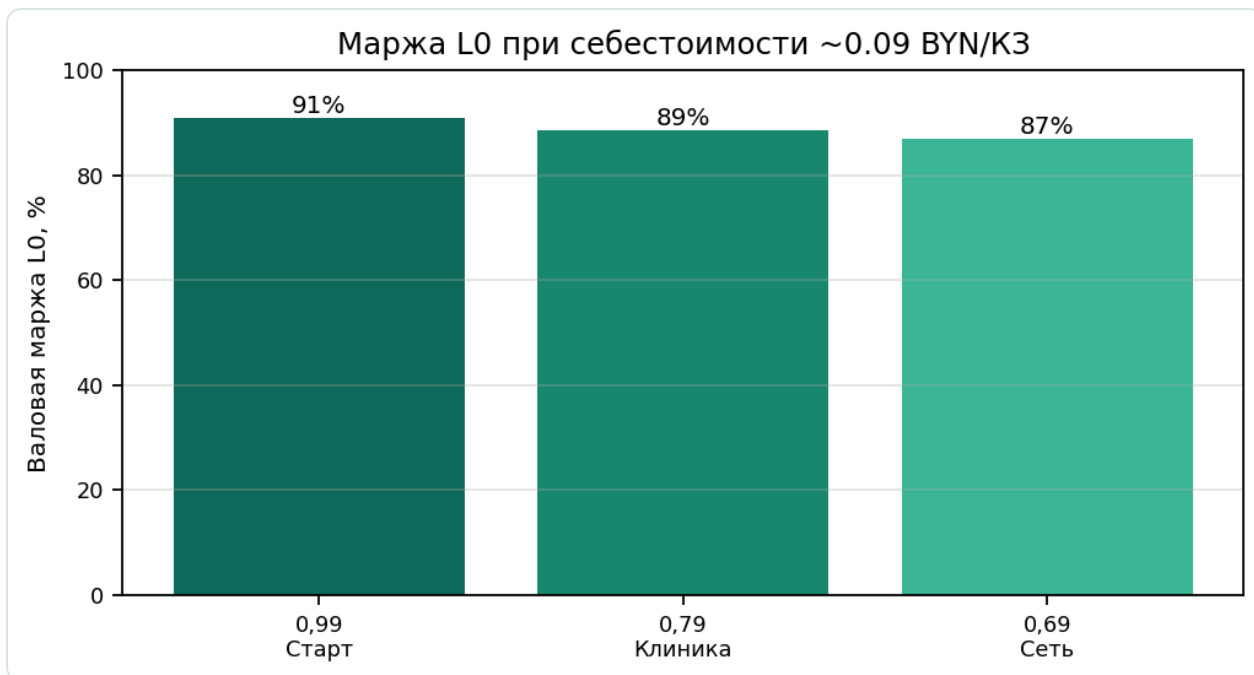
Структура ОРЕХ



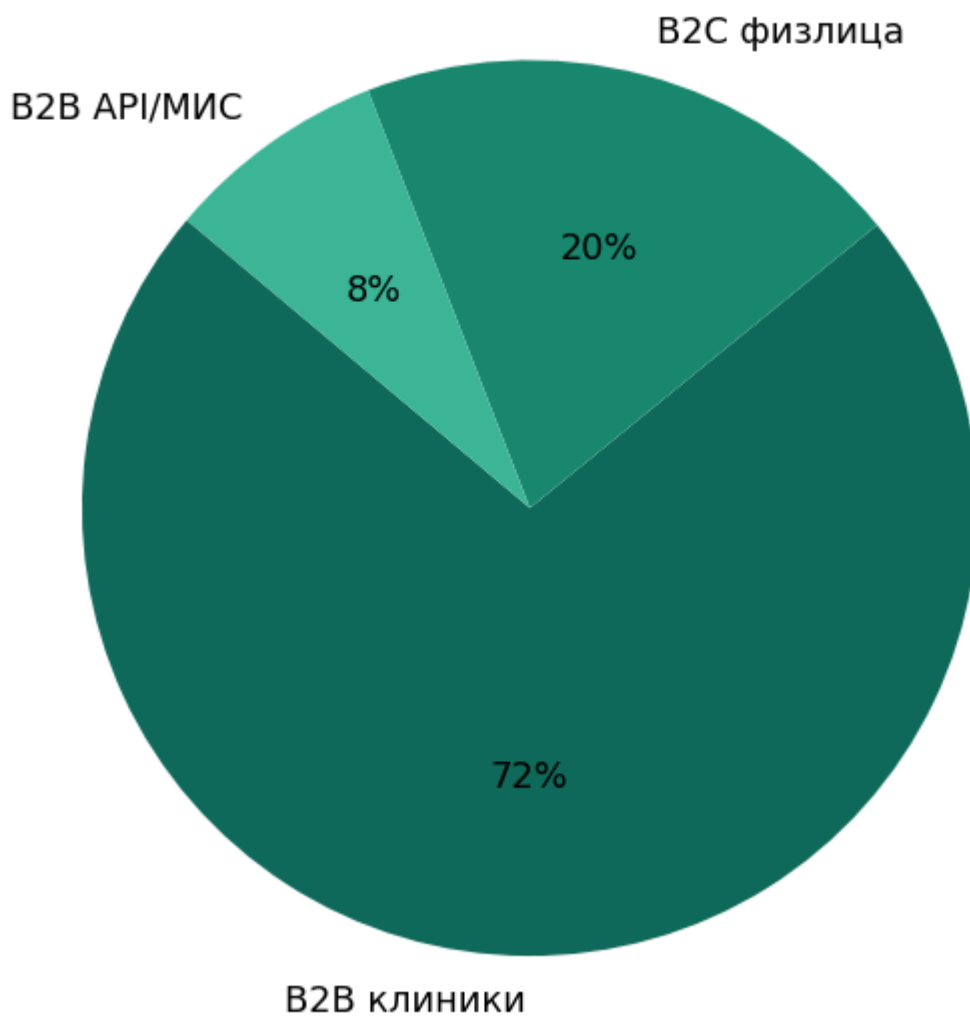
Тарифная лестница B2B



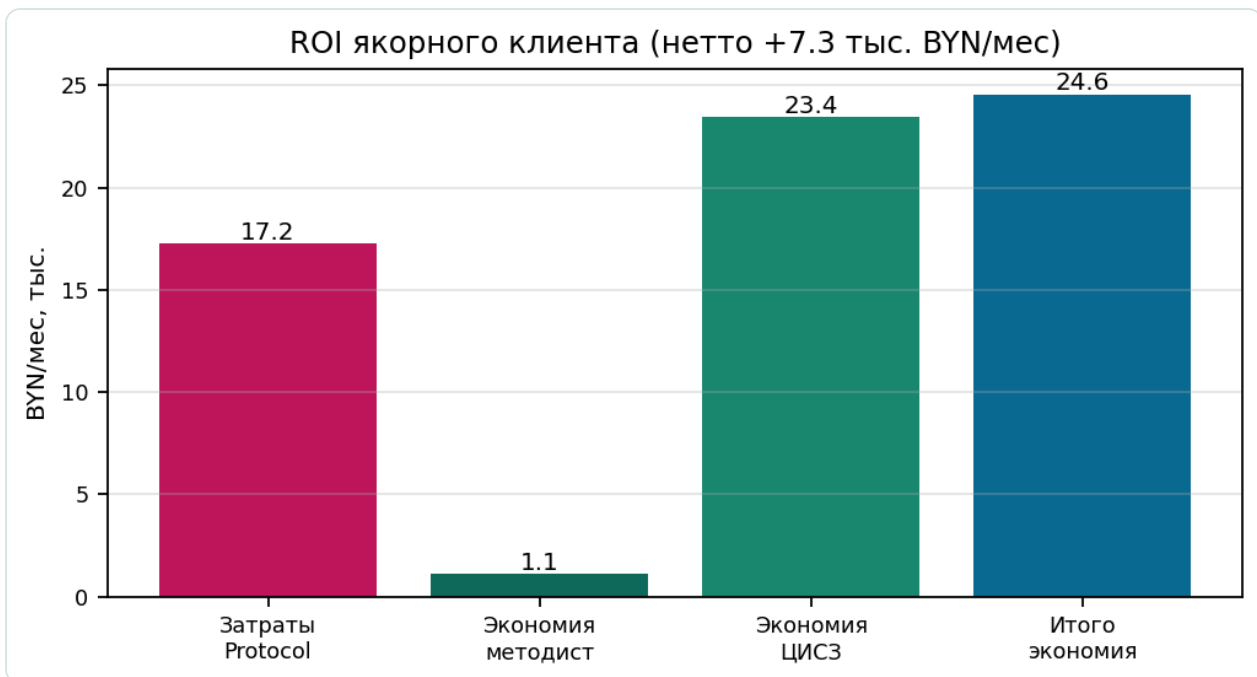
Маржа L0



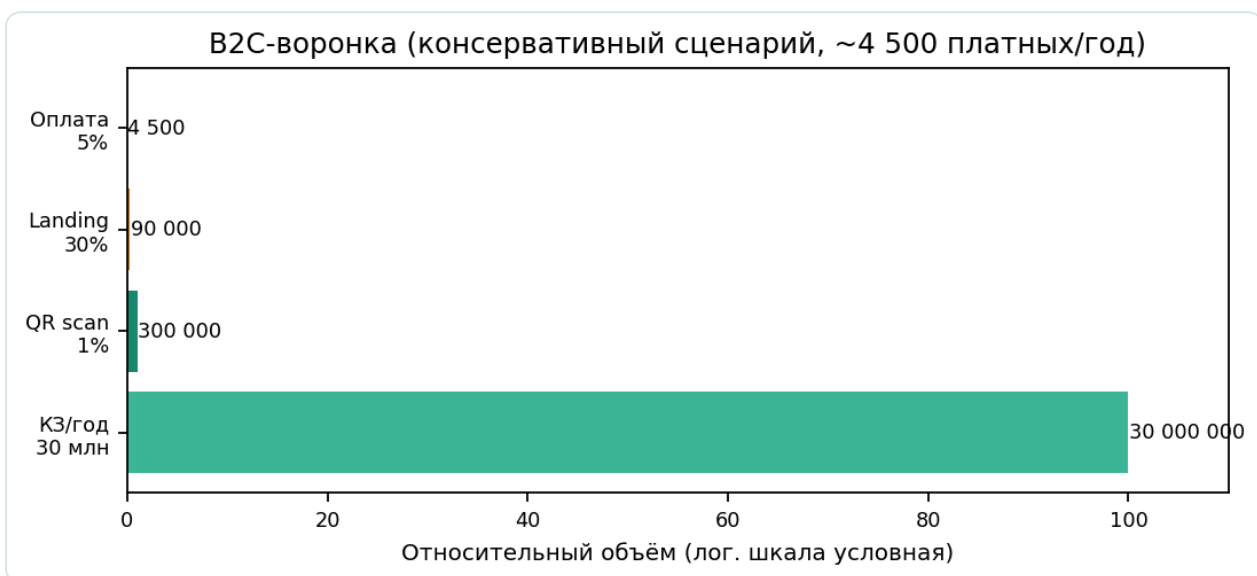
Структура выручки, год 3 (оценка)



ROI якорного клиента



B2C-воронка



Сертификат ГКНТ: 23,982 BYN (571 б.в. × 42 BYN). Запрос направлен на интеграцию МИС, on-prem L0 и масштабирование на 5-10 частных ОЗ к 2028 г.